

Sénologie normale et pathologique

Table des matières

I.Introduction :	1
II.Interrogatoire :	1
III. Méthodes d'examen :	2
A. Inspection :	2
B. Palpation :	3
IV. Résultats :	3
1. A l'état normal	3
1.1. Au cours du cycle menstruel :	3
1.2. Au cours de la grossesse :	3
1.3. Après la ménopause :	3
2. A l'état pathologique	3
2.1. L'abcès du sein :	3
2.2. La tumeur bénigne :	4
2.3. Dans le cancer du sein :	4
2.4. La gynécomastie :	4
V. L'auto-examen des seins :	4
Références bibliographiques :	5

I. Introduction

Le recueil de l'observation est essentiel en sénologie et comprend : Le recueil minutieux des antécédents de la patiente, l'inspection des seins, la palpation des deux seins, mais également l'examen des creux axillaires, des creux sus et sous-claviculaires ainsi que la recherche d'un écoulement mamelonnaire. L'examen des seins doit être bilatéral et comparatif.

Il est réalisé en début de cycle chez les patientes non ménopausées et toujours à la même période chez les patientes ménopausées sous traitement hormonal substitutif (THS).

II. Interrogatoire

A/Motif de consultation : 2 situations sont possibles : soit la patiente consulte pour un symptôme mammaire, soit il s'agit d'un examen systématique dans le cadre de l'examen gynécologique.

Les principaux motifs de consultation (examen orienté) sont :

- ✓ Perception d'une tumeur (« nodule du sein ») à l'autoexamen.
- ✓ Douleurs mammaires (mastodynies).
- ✓ Écoulement du mamelon (spontané ou provoqué)
- ✓ Autres motifs de consultation en sénologie :
 - Placard inflammatoire +/- localisé
 - Découverte d'une adénopathie axillaire
 - Lésion crouteuse du mamelon (eczématiforme), ou invagination récente du mamelon
 - Anomalie radiologique (dépistage systématique)

B/ Il faut préciser l'évolutivité des signes et les signes d'accompagnement éventuels.

α tumeur (évolution, mode de découverte, vitesse de croissance...)

α mastodynies (cyclique / non cyclique) ...

C/ L'interrogatoire recherchera

- Antécédents familiaux de cancer
- Antécédents personnels (pathologie mammaire, autres cancers,...)
- Histoire de la vie reproductive : ménarches, âge de la 1ère grossesse, nombre et date des grossesses, allaitement ; ménopause (date, traitements hormonaux) ...
- cycles menstruels, date des dernières menstruations...
- traitements hormonaux en cours (contraception ...)
- Les facteurs de risque du cancer du sein :
 - Âge > 40 ans (pic de fréquence 60 – 64 ans)
 - Antécédents familiaux de cancer du sein : chez la mère, une tante, une sœur multiplie, pour la patiente, le risque par 3.
 - Antécédents personnels de cancer du sein
 - Situations traduisant une exposition endogène aux estrogènes : puberté précoce (risque x 1,5 à 1,8) ; ménopause tardive (> 55 ans = risque x 2) ; 1ère grossesse tardive ; obésité post ménopausique.
 - Exposition aux estrogènes exogènes : pilule ; traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause
 - Certaines mastopathies bénignes comportent un risque majoré.
 - Exposition aux radiations ionisantes ou traitement (Hodgkin)
 - Contexte socio-économique
 - Facteurs environnementaux
 - Haut niveau socio-économique ++
 - Alimentation riche en graisses saturées +
 - Rôle protecteur du régime crétois
 - Hygiène de vie + (alcool, rôle protecteur de l'activité sportive régulière) ✓ Exposition aux pesticides organochlorés.

III. Méthodes d'examen

L'examen des seins doit se faire en première partie du cycle, (10ème jour), car en 2ème partie du cycle, le sein est souvent congestif, douloureux, et difficile à examiner.

L'examen doit être minutieux, bilatéral et comparatif, patiente dévêtue jusqu'à la ceinture, assise mains posées sur les hanches, puis couchée les mains le long du corps puis derrière la tête.

A. Inspection

- Conditions : L'examen comparatif, éclairage correct (direct et tangentiel), si signes d'appel, commencer par le côté sain. L'inspection se fait sur la malade dévêtue jusqu'à la ceinture, en position assise face à l'examineur, les mains posées sur les genoux joints, puis les bras levés au-dessus de la tête de manière comparative.

Déroulement : il faut inspecter successivement de face et de profil, en changeant de position : assise, bras pendants puis levés (ce qui « remonte » les seins), puis aux hanches ; patiente penchée en avant, patiente en décubitus dorsal. L'inspection apprécie :

- a) les seins : volume ; forme: +/- ptosés ; symétrie ; présence de tuméfaction.
- b) le mamelon : situation ; symétrie ; relief ; invagination éventuelle (date d'apparition) ; lésion cutanée.
- c) la peau : couleur, œdème, ulcération, déformation ; cicatrices antérieures ; recherche d'une rétraction cutanée traduite par une ride, par une rupture de la ligne du galbe.

B. Palpation

- Conditions : Les mains bien réchauffées. Elle se fait sur la malade assise les bras baissés, puis les bras levés au-dessus de la tête et en position couchée en plaçant un petit coussin sous l'épaule du côté du sein que l'on veut examiner ; ainsi le sein s'étale sur la paroi thoracique, ce qui facilite l'examen. Déroulement : Avec une main, à plat (pulpe des doigts 1 ou 2), « sans pincer », la palpation doit être douce et se fait quadrant par quadrant (rayons de roue), dans un mouvement rotatoire de va-et-vient ; sans oublier le prolongement axillaire, le sillon sous mammaire ; et le mamelon.

La palpation des seins permet de rechercher une formation pathologique dont il faut préciser les caractères : unique ou multiple ; taille (en centimètres) ; limites (difficiles à préciser si obèse) : régulières ou non ; localisation (quadrant) ; profondeur ; distance par rapport au mamelon ; consistance (molle, élastique, dure) ; température locale en regard ; sensibilité ; mobilité ou non d'un nodule.

La palpation permet également de rechercher un écoulement mamelonnaire : Pincer délicatement des mamelons avec une pression sur les différents quadrants à la recherche d'un écoulement dont il faudra noter : caractère spontané ou provoqué (+/- facile) ; couleur : lactescent, sanglant, séreux, verdâtre, marron ; caractère uni ou bilatéral ; caractère uni ou multipore.

La palpation des creux axillaires et des creux sus-claviculaires doit être systématique à la recherche d'adénopathies (nombre, consistance, sensibilité, mobilité, schéma daté).

IV. Résultats

1. A l'état normal chez la femme après la puberté, les seins vont subir des modifications au cours des 3 phases de la vie génitale.

1.1. Au cours du cycle menstruel : après l'ovulation dans la deuxième partie du cycle, on note une augmentation de volume des seins qui atteint son maximum dans la période prémenstruelle, les seins sont alors engorgés, lobulés et douloureux.

Dans la première partie du cycle le sein est plus souple et plus homogène.

1.2. Au cours de la grossesse : les seins augmentent de volume, l'aréole s'agrandit et elle est hyperpigmentée, cette hypertrophie intéresse le tissu mammaire présent dans le creux axillaire, ainsi les aisselles paraissent plus remplies. A la palpation, les seins sont fermes et nettement lobulés.

1.3. Après la ménopause : les seins ont une consistance fibreuse et nodulaire.

2. A l'état pathologique : les seins peuvent être le siège de différents remaniements pathologiques: l'abcès du sein, les tumeurs et la gynécomastie.

2.1. L'abcès du sein : survient essentiellement en période d'allaitement, il va évoluer en 2 phases :

— Au début : la malade présente une douleur très vive, qui l'oblige à suspendre l'allaitement, et une hyperthermie. La palpation douce retrouve, à la partie inféro--externe le plus souvent du sein atteint, une tuméfaction dure, très douloureuse. Par le mamelon s'écoule, lors de l'expression douce du sein, du lait mélangé à du pus.

— En l'absence de traitement, quelques jours plus tard apparaît, une rougeur cutanée, à la palpation la tuméfaction devient fluctuante et on retrouve une adénopathie axillaire.

2.2. La tumeur bénigne : à l'inspection une tumeur bénigne n'entraîne pas de modification de la morphologie du sein ; à la palpation elle réalise une tuméfaction bien limitée, mobile par rapport à la peau et par rapport au plan musculaire. Il n'existe jamais d'adénopathie axillaire.

2.3. Dans le cancer du sein, l'inspection peut mettre en évidence :

— Une rétraction cutanée ou fossette qui est un signe important de malignité, elle se manifeste sous forme d'une dépression de la peau au niveau du sein qui peut être accompagnée d'une déviation du mamelon dirigée vers la lésion, elle est due à la traction anormale exercée par la tumeur sur les ligaments suspenseurs du sein , elle se recherche soit en demandant à la malade de lever les bras audessus de la tête, soit de presser fortement les paumes des mains l'une contre l'autre (ce qui entraîne une contraction des pectoraux et exagère ainsi le phénomène de rétraction).

— Une rétraction du mamelon : suivant le siège de la tumeur, la rétraction cutanée peut être remplacée par une rétraction du mamelon.

— Le signe de « la peau d'orange » est en rapport avec un lymphœdème (œdème causé par l'obstruction des canaux lymphatiques) ; à l'inspection il se traduit par des pores et des follicules pileux plus prononcés et à la palpation la peau paraît épaissie capitonnée.

La palpation va retrouver une tuméfaction de consistance variable qui se mobilise en masse avec le sein; parfois cette tuméfaction est adhérente au muscle sous-jacent que l'on met en tension par la manœuvre de l'adduction contrariée de Tillaux : le médecin s'oppose à l'adduction du bras de la malade (ce qui met en tension le muscle grand pectoral); on pince alors la glande à pleine main et on essaie de la mobiliser ,en cas de cancer, la mobilité est diminuée ou abolie; enfin la palpation du creux axillaire peut mettre en évidence une adénopathie.

A noter que tous ces signes sont ceux d'un cancer du sein à un stade avancé ; au début un cancer du sein peut avoir tous les caractères d'une tumeur bénigne et seules les investigations paracliniques : la mammographie, la ponction mais surtout l'examen anatomo-pathologique après exérèse permettront de trancher.

2.4. La gynécomastie : est définie comme une hypertrophie mammaire pathologique apparaissant soit chez l'homme soit chez la petite fille avant la puberté. Elle peut être due à un traitement hormonal

par les œstrogènes ou accompagner un cancer ou une cirrhose, maladie rénale chronique, médicaments et substances toxiques (voir tableau 1 en annexe).

V. L'auto-examen des seins

L'auto-examen des seins est d'un intérêt certain pour la détection précoce du cancer du sein : Le dépistage. L'auto-examen des seins ou autopalpation regroupe un ensemble de gestes simples qui, pratiqués tous les mois, après les règles, permettent de détecter toute anomalie et de la signaler au médecin. L'auto-palpation est une pratique très positive et importante pour toutes les femmes.

L'autopalpation devrait être répétée au moins une fois chaque mois, à la même période.

Les gestes de l'auto-palpation :

- ✓ Inspecter les deux seins et vérifier qu'il n'y a rien d'anormal : par exemple un écoulement par le mamelon d'un liquide, ou encore de sang, crevasses, fossettes, plis ou peau d'orange sur le sein.
- ✓ Lever le bras droit : Avec les trois doigts de la main gauche, palper le sein droit, fermement, attentivement et complètement. En commençant par la partie externe, parcourir le sein en effectuant de petits cercles avec les bouts des doigts.
- ✓ Une attention particulière doit être portée à la zone entre le sein et l'aisselle, cette dernière comprise. Chercher toute tuméfaction ou toute induration anormale sous la peau.
- ✓ Terminer par le mamelon : Presser délicatement le mamelon et vérifier qu'aucun écoulement ne se produit. Si c'est le cas, prévenir le médecin sans attendre. ✓ Répéter l'auto-examen sur le sein gauche.

Références bibliographiques

Rose-Marie-Hamladji, Précis de sémiologie, OPU Alger.

http://campus.cerimes.fr/maieutique/UE-gynecologie/examen_gynecologique/site/html/2_2.html

<https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2009/revue-medicale-suisse-198/evaluation-et-prise-en-charge-d-une-gynecomastie>

Tableau1 : Médicaments et substances associées à la gynécomastie

Liste non exhaustive. hCG: human chorionic gonadotrophin

Anti-androgènes/inhibiteurs de la synthèse des androgènes • Acétate de cyprotérone • Flutamide, bicalutamide • Finastéride • Spironolactone • Kétoconazole • Traitement anti-VIH (éfavirenz, antiprotéases)	• Amphétamines • Héroïne, méthadone • Marijuana
Antibiotiques • Ethionamide • Isoniazide • Métronidazole	Hormones • Androgènes, œstrogènes • Stéroïdes anabolisants • hCG • Hormone de croissance
Antiulcéreux • Cimétidine, ranitidine • Oméprazole	Psychotropes • Diazépam • Halopéridol • Phénothiazines • Antidépresseurs tricycliques
Agents chimiothérapeutiques • Agents alkylants • Méthotrexate • Vincristine, cisplatine, imatinib	Divers • IEC (énalapril, captopril) • Anticalciques (nifédipine) • Amiodarone, digitoxine • Métoclopramide • Phénytoïne • Théophylline
Toxiques • Alcool	